

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	哮喘 Croup				
編號	A31000-Q03-W-N11	制定者	R10 陳倩芳	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.6 版/12 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解哮喘的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，使護理人員有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

哮喘(croup)是造成小兒急性喘鳴(stridor)最常見的一種疾病，為一種病毒感染，常見的病毒包括parainfluenza等，造成喉部及聲門下黏膜水腫而引起呼吸道阻塞，病毒性哮喘好發於1-3歲兒童，細菌性感染哮喘則好發於3-6歲兒童。

（二）症狀

1. 病毒性感染哮喘：病童通常會有咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒等感冒症狀，持續1-3 天。之後聲音沙啞(hoarseness)因病變發生在聲門下方的喉部，以致發炎腫脹擴及聲帶，接著呼吸道分泌黏液的增加，造成呼吸道受阻，會發出像狗吠聲音的咳嗽(barking cough)，白天或晚上都會發作；但若晚上發作則症狀會更嚴重。此外，幼兒的氣管內徑較小，感染發炎後，很快的出現出血和腫脹，導致吸氣時空氣氣流阻力增加，產生吸氣喘鳴(inspiratory stridor)。嚴重時，病童會出現呼吸窘迫及呼吸系統衰竭，需立即住院治療。

2. 細菌性感染哮喘：感染位置在聲門上方，會有吞嚥疼痛(dysphasia)與發音困難

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/12

(dysphoina)，此外還有流口水(drooling)與呼吸窘迫(distressed respiratory effects)的情形，即“4D”症狀。細菌性感染哮喘通常較病毒性危險，因為其發生又急又快，可能導致會厭水腫，阻塞呼吸道而發生窒息。

(三) 常見檢查

- 1.血液檢查及培養(blood routine & culture)。
- 2.動脈血氧分析(blood gas)。
- 3.頸部 X-ray。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：

(1)Aminophylline

- A. 作用：具有冠狀動脈擴張作用，且有緩解支氣管痙攣之作用。
- B. 副作用：躁動、心跳過快。

(2)Bricanyl

- A. 作用：支氣管擴張劑腎上腺 β_2 感受體刺激劑，能舒緩支氣管平滑肌，改進膿性粘液的運送，清除粘膜纖毛的異物及舒緩肌肉。
- B. 副作用：顫抖、痙攣、心悸。

(3)Cefamezine

- A. 作用：與青黴素結合蛋白(PBP)有強力結合的親和性，而阻止細菌細胞壁的合成。具有殺菌作用，抗菌範圍廣，包括 G(+)及 G(-)菌，特別是對 G(+)之 Staphylococcus, Streptococcus, S. pneumoniae 及 G(-)之 E.coli, K. pneumoniae, Proteus mirabilis 具有優異的抗菌力。
- B. 副作用：腹瀉、噁心、嘔吐。

(4)Decadron

- A. 作用：一種糖皮質類固醇類藥物，其作用為抑制細胞有絲分裂→增加細胞分化，促進酵素的作用，參與表面作用劑的儲存和分泌皮質類固醇。
- B. 副作用：食慾增加，消化不良，神經質或坐立不安。

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/12

(5)Ventolin

A. 作用：乙型腎上腺素興奮劑，對支氣管肌肉之第二類乙感受體有獨特功效，作用於支氣管肌肉細胞，使支氣管能放鬆擴張。

B. 副作用：會引起骨骼肌戰慄，尤其是手。輕微的心跳過快、心悸。

(6)Zithromax

A. 作用：抑制細菌蛋白質之合成。

B. 副作用：噁心、嘔吐、下痢、腹痛。

(7)Epinephrine

A. 作用：蒸氣吸入使用，可使局部血管收縮、減輕喉部水腫，改善症狀。

B. 副作用：鼻灼熱或刺痛、心悸、頭痛、眩暈、出汗、心跳過快。

2. 支持療法。

3. 氧氣帳。

（五）護理問題

1. 呼吸道清除功能不良／分泌物黏稠。

2. 發燒／感染。

3. 無法有效呼吸／與咽喉水腫導致呼吸道阻塞有關。

4. 照顧者感到緊張／與照顧者不了解哮喘疾病過程及治療措施有關。

（六）護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／分泌物黏稠

(1) 教導正確有效率深呼吸、咳嗽。

(2) 聽診呼吸聲，評估並記錄分泌物的量、顏色、濃稠度。

(3) 聽診呼吸聲，觀察並記錄呼吸型態、次數、發紺情形、皮膚顏色視病童需要給予姿位引流。

(4) 給予噴霧治療、扣擊、抽痰。

(5) 急性期發作後，病童呼吸道分泌物會增加，視情況給予病童抽痰，以保持呼吸道暢通。

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/12

(6) 床旁隨時備妥抽痰器。

(7) 抽痰前後予 100%O₂，以提高含氧量。

(8) 以無菌技術抽痰，動作宜輕柔，避免黏膜損傷，壓力維持在 60-120mmHg
抽吸時間不超過 15 秒。

(9) 採分段餵食，並在餵食後予以排氣，抬高床頭 45-60 度，並留意有無嘔吐。

(10) 如呼吸過速，勿由口進食。

(11) 依醫囑給予靜脈補充體液，並維持適當的滴數。

(12) 依醫囑給予藥物，以減少氣管阻塞並評估效果及副作用。

2. 發燒／感染

(1) 向病童及其家屬說明體溫上升的原因。

(2) 教導病童及主要照顧者降低體溫的方法。

(3) 調整衣物被蓋及提供舒適室溫(24-26°C)並維持通風。

(4) 病童發燒引起寒顫時，在其四肢覆蓋毛巾保暖。

(5) 冰枕或冰寶使用。

(6) 病童流汗時給予擦乾，建議穿棉質衣服保持舒適及乾爽。

(7) 協助追蹤各項相關之檢驗報告結果。

(8) 依醫囑給予溫水拭浴(水溫 27-37°C，毛巾沾濕自病童雙側腹股溝、腿內側、
膝窩、足跟、擦拭 8 分鐘)。

(9) 依醫囑給予解熱劑。

(10) 每 30 分鐘測量生命徵象至穩定並記錄。

(11) 依醫囑給予靜脈點滴輸液。

(12) 依醫囑給予抗生素注射。

3. 無法有效呼吸／與咽喉水腫導致呼吸道阻塞有關

(1) 依醫囑給予氧氣治療：

A. 使用氧氣帳，給予潮濕氧氣，以改善咽部痙攣情形；不可抽痰。

B. 若是病毒性感染哮喘，使用噴霧治療時可加入 epinephrine；若是細菌性

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/12

感染哮喘，則可依細菌培養結果，給予適當之抗生素。

(2)室內的空氣應保持溫暖而潮濕。

(3)若病童有呼吸困難的現象，可協助其採半坐臥式。

(4)急性期發作後，視情況給予病童抽痰，以保持呼吸道暢通。

(5)床旁應有氣切用物，以備急救時使用。

4.照顧者感到緊張／與照顧者不了解哮喘疾病過程及氧氣帳治療措施有關

(1)評估病童及家屬對哮喘的瞭解程度。

(2)提供哮喘衛教單張並與指導並說明使用氧氣帳的目的及過程。

(3)鼓勵家屬發問及解答其疑問。

(4)介紹治療成功病童、減輕其焦慮並給予心理支持。

(5)完成氧氣帳使用前的各項準備及護理。

(6)告知家屬若病童不願意待在氧氣帳內，可利用玩具或進入氧氣帳內陪伴病童。

(7)病童若有任何不適或異常，請家屬立即通知護理人員。

(七) 衛教指導

1. 疾病衛教指導

(1)教導父母若病童出現呼吸喘、吸氣時有哮鳴(stridor)、聲音沙啞、類似狗吠聲的咳嗽時，應供小孩一安靜且具有高濕度空氣之環境，例如使用家中之浴室，先放熱水，等熱蒸氣瀰漫整個浴室後，再讓病童到浴室中吸濕空氣 15 分鐘，以幫助呼吸道擴張。過程中需注意病童安全及環境溫度，以免病童遭熱溼氣燙傷。若症狀仍無減輕，需立即送醫治療。

(2)有些咳嗽藥或感冒糖漿有乾燥作用，會導致呼吸道之分泌物濃稠，故要教導父母不要給予病童未經醫師指示之咳嗽藥或感冒糖漿。

(3)避免小孩進出公共場合，或與上呼吸道感染的病童接觸。

(4)天氣轉冷時，要預防感冒，以免誘發哮喘。

(5)教導父母盡量讓病童處在溫暖、潮濕的環境中，而盡量避免在寒冷乾燥的環

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/12

境。從炎熱的戶外進入冷氣房時，要注意溫差的變化，適時調整冷氣設定溫度，或增加衣物以保暖，避免冷空氣造成呼吸道的收縮。

2. 發燒的處理

(1) 衛教發燒處理的常規。

36.0~37°C：正常；37.0~38°C：微燒冰枕及溫水擦拭浴；39°C 以上：高燒並於醫師指示下給予退燒藥。

(2) 給予冰寶使用，並檢測冰寶溫度隨時更換，使用時間 20-30 分鐘，若長時間使用，至少間隔 30-60 分鐘，約 2-3 小時更換一次。

(3) 環境及衣物的調節。

- A. 合宜的室溫 22-27°C 溼度 60%。
- B. 必要時打開窗戶，促進空氣流通。
- C. 保持安靜，避免噪音。
- D. 寒顫發抖時，可先加被蓋保暖。
- E. 寒顫停止高燒持續時，應慢慢移除被蓋。
- F. 當衣物出汗潮濕時，隨時更換。

(4) 水份的補充

- A. 多喝水：每日約 3000cc。
- B. 經由點滴補充水份及電解質。

(5) 保持清潔舒適

- A. 口腔護理：清潔口腔如漱口。
- B. 當口唇乾裂時可擦甘油或脣膏。

(6) 適當的臥位

- A. 使用枕頭被褥維持舒適臥位。
- B. 協助更換姿勢。
- C. 減少活動，減少體熱產生。

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/12

(7)洗澡或溫水拭浴

- A.溫水拭浴，水溫 27°C~37°C，約 20~30 分鐘，促使皮膚微血管擴張，並藉由水氣蒸發而達散熱效果。
- B.溫水輕拍身體四肢、腋下等部位。

(8)飲食攝取

- A.低脂、低糖、高蛋白、高維生素。
- B.易消化的食物。
- C.依病童的喜好。
- D.可引起食慾的食物。

(9)隨時量體溫及注意體溫變化。

3. 小兒拍背

- (1)病童應穿較薄的衣服，避免拍痰時產生痛感。
- (2)拍痰時避免戴手錶、手鍊或留指甲，以避免造成傷害。
- (3)幫病童拍痰應避免在飯後做，最好在吃東西前後一小時做，以防嘔吐拍痰一天約二到三次，若痰液較多者可每小時做一次。
- (4)拍擊時應考慮小孩的安全及舒服，應給予適當衣物來保暖。
- (5)當發現病童有痰液時，可多喝水以利痰液排出。
- (6)有些人以為努力拍痰就能除去痰液，但忽略了太粘稠的痰液，往往很難只靠拍痰排出，所以加上噴霧治療是很重要的。

(7)拍背方法

- A. 治療者弓起手呈杯狀。
- B. 仰躺頭高，由肩部往下拍前胸左右側。
- C. 臉朝下頭高，由肩部往下拍後背的左右側。
- D. 臉朝上頭低，由肋骨往肩部拍前胸。
- E. 側躺手臂提起，由腰往腋下拍擊。
- F. 臉朝下頭低，由腰往肩部拍後背左右側。

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	8/12

(8) 氧氣帳的注意事項：

- A. 帳內可放置玩具及照顧用物，但不可有易產生火花或其他易燃材質並嚴禁煙火，以免引發火災。
- B. 帳內空間較大，可以在帳內玩耍（帶患孩喜歡之玩具入內，禁帶有毛之玩偶或玩具，以避免產生靜電作用）。
- C. 保持病童身體乾燥及注意保暖，隨時更衣或擦乾身體。
- D. 若帳內過熱、過悶或過冷，可請醫護人員予以協助調整或更換。
- E. 患孩有被隔離的焦慮與不安全感→易哭鬧、不安、拒絕等情緒，父母其中一人可入帳內陪伴予安撫減輕焦慮。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）蔡綠蓉(2021)．兒童呼吸系統疾病及其護理．於陳月枝總校閱，實用兒科護理（九版，349-424 頁）．台北：華杏。
- （二）蔣立琦、蔡綠蓉、黃靜微、邱淑如、毛新春、吳書雅...吳佩玲(2020)．兒童呼吸系統疾病與護理．於黃美智、蔣立琦總校閱，兒科護理學（第六版，461-467 頁）．台北：永大。

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	9/12

七、附件

(略)

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	10/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容與錯別字	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
101.8.31	2.2	修改說明內容與錯別字	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 第三項第(四)、(六)、(七)目部份內容刪修。 2. 參考文獻新增於內文。 3. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	修訂第六項參考文獻資料	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 1(3)說明內容修訂。 3. 第三項第六目之 1(8)修訂水溫。 4. 第三項第七目之 2(7)A.說明內容修訂。 5. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 6. 更新第六項參考文獻資料	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.5	1. 更新第三項第(五)目護理問題及第(六)目護理措施。 2. 更新第六項參考文獻資料。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.6	1. 第三項第三目：英文大小寫修訂 2. 第三項第四目第 1 點之(1)A：刪除錯字「肌」	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	哮喘	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N11	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註